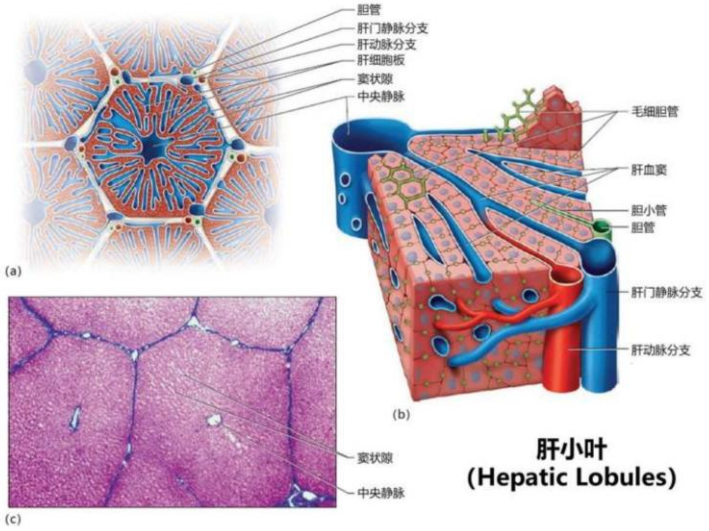
六、急性梗阻性化脓性胆管炎 AOSC　胆道梗阻严重,压力非常高

1.病因

①胆管梗阻：胆管结石、胆管癌、胆肠吻合口狭窄等

②细菌感染：大肠杆菌多见

2.胆血反流：胆道压力>15cmH_2O 细菌可在外周血出现，胆道压力<20 胆汁及淋巴液培养阴性、>25 迅速变为阳性



征象可以不全部出现

3.典型表现 **Reynolds 五联征**：Charcot 三联征（胆绞痛+黄疸+寒战高热）、中枢抑制、休克（血压＜90/60）。WBC 明显↑常＞20×10^9/L（以中性粒细胞为主）、Plt 可↓（疼-黄-烧-很烧、烧傻了烧休克了）

严重感染抑制骨髓造血

减轻胆管压力

4.治疗（胆囊结石切胆囊、胆管结石取石头、AOSC 要减压）能减压的:PTCD ENBD T管 PTGD 胆囊造口

①**最关键：急诊解除胆管梗阻、降低胆管压力**——经皮经肝胆管穿刺引流 **PTCD**、鼻胆管引流 **ENBD**、或胆总管切开**减压+T 管引流**

首选(微创),高位胆管梗阻首选PTCD

②**同时抗休克**（补平衡盐和胶体液），无好转应纠酸

大量酸性产物堆积导致后微A、毛细血管前括约肌舒张,血进入微循环,有效循环血量↓,此时补液效果不佳

③三代头孢+甲硝唑、甚至碳青霉烯类抗生素，可用糖皮质激素

④胆总管切开减压时若发现肝脏单发脓肿、胆囊结石应一并处理

⑤1-3 月后彻底手术以避免复发

默认肝外胆管,不包括肝内胆管
肝内胆管发生恶性肿瘤属于原发性肝癌的范畴
原发性肝癌包括①肝细胞癌②肝内胆管上皮癌
③混合性肝癌

七、胆管癌

1.病因：胆管结石（1/3 的胆管癌合并胆管结石）、硬化性胆管炎、溃疡性结肠炎、先天性胆管扩张症、胆管囊肿空肠吻合术后（胆管结石硬、U 先扩吻合）

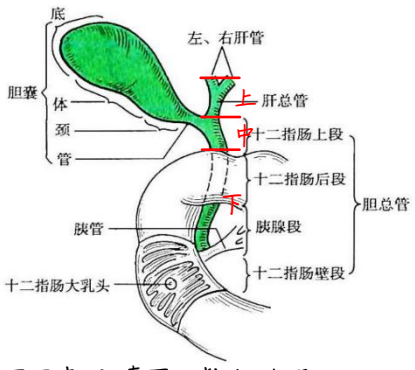
UC

2.分类

①下段胆管癌：十二指肠上缘至十二指肠乳头

②中段胆管癌：胆囊管开口至十二指肠上缘

③上段/肝门部胆管癌：左右肝管至胆囊管开口以上



（上段多见靠近肝血供好）

长得越快,有生存优势

VS肝外胆管结石偏下,主要在汇合的地方,比如肝总管、胆总管的下段

中下段胆管癌:胆囊内胆汁下不来,胆囊可以憋大,出现courvoisier征
上段胆管癌:胆汁进不到胆囊内,胆囊长期接受不到胆汁,出现废用性萎缩,因此上段胆管癌不可能出现胆囊肿大,反而可能胆囊缩小